

10_fristen_und_leistungsdaten.csv

Ereignis	Datum	Notiz
Antrag Erwerbsminderungsrente	2026-03-12	Online mit Hilfe der Tochter
Reha Beginn	2026-04-08	Bad Zwesten
Reha Ende	2026-04-29	arbeitsunfähig entlassen
Bescheid DRV	2026-06-19	Ablehnung
Zugang Bescheid	2026-06-24	Briefkasten laut Tochter
Widerspruchsfrist	2026-07-24	ein Monat nach Zugang
Krankengeld voraussichtlich bis	2027-03-03	Aussteuerung vorbereiten
Akteneinsicht beantragen	2026-07-05	noch offen

Ablehnungsbescheid der Deutschen Rentenversicherung Hessen

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Städelstraße 28, 60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069 6052-0

Versicherungsnummer: 14 140271 K 507

Kennzeichen: EM-KRU-2026-0312

Datum: 19.06.2026

Frau

Sabine Krüger

Leipziger Straße 214

34123 Kassel

Ihr Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung vom 12.03.2026

Sehr geehrte Frau Krüger,

Ihren Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung vom 12.03.2026 lehnen wir ab. Sie sind weder voll noch teilweise erwerbsgemindert.

Begründung

Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung besteht, wenn ein Versicherter wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Teilweise erwerbsgemindert ist, wer unter diesen Bedingungen nicht mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig sein kann.

Zur Beurteilung Ihres Leistungsvermögens haben wir die von Ihnen eingereichten Befundberichte, die Unterlagen Ihrer Krankenkasse sowie den Entlassungsbericht der medizinischen Rehabilitation in Bad Zwesten vom 08.04.2026 bis 29.04.2026 durch unseren Sozialmedizinischen Dienst auswerten lassen.

Danach bestehen bei Ihnen folgende Gesundheitsstörungen mit Auswirkung auf das Leistungsvermögen:

1. Chronische Lumboischialgie links bei Spinalkanalstenose L4/L5 mit Bandscheibenprotrusion und Facettengelenksarthrosen.
2. Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode, mit Schlafstörung.
3. Arterielle Hypertonie, Adipositas Grad I, beginnende Polyneuropathie.

Nach dem Ergebnis der sozialmedizinischen Auswertung sind Sie noch in der Lage, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes leichte Tätigkeiten mindestens sechs Stunden täglich auszuüben. Zu vermeiden sind schweres Heben und Tragen, häufiges Bücken, Zwangshaltungen, dauerndes Stehen sowie Tätigkeiten unter Akkord- und Fließbandbedingungen. Diese qualitativen Einschränkungen führen nicht zu einer rentenrechtlich relevanten Minderung des zeitlichen Leistungsvermögens. Die Wegefähigkeit ist nach den vorliegenden Unterlagen gegeben.

Eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit kommt nicht in Betracht. Sie sind nach dem 1. Januar 1961 geboren; ein Berufsschutz besteht daher nicht. Auf die Frage, ob Sie Ihre letzte Tätigkeit als Kassiererin und stellvertretende Schichtleitung noch ausüben können, kommt es nicht an. Die Benennung einer konkreten Verweisungstätigkeit ist entbehrlich, weil ein Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden täglich für den allgemeinen Arbeitsmarkt vorliegt.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen wären im Übrigen erfüllt; hierauf kam es nach dem Ergebnis der medizinischen Prüfung nicht mehr an.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form mit qualifizierter elektronischer Signatur oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen, Städelstraße 28, 60596 Frankfurt am Main, oder bei jeder anderen Dienststelle der Deutschen Rentenversicherung einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Reinelt

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Reha-Entlassungsbericht (Auszug)

Kurhessen-Klinik Bad Zwesten

Fachklinik für Orthopädie und Psychosomatik

Am Kurpark 12, 34596 Bad Zwesten

Chefarzt: Dr. med. Volkhard Stemmler

Rehabilitandin: Sabine Krüger, geboren am 14.02.1971

Kostenträger: Deutsche Rentenversicherung Hessen

Versicherungsnummer: 14 140271 K 507

Aufenthalt: 08.04.2026 bis 29.04.2026

Bericht vom: 06.05.2026

Diagnosen

1. Chronische Lumboischialgie links bei Spinalkanalstenose L4/L5 (M48.06).
2. Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode (F33.1).
3. Nichtorganische Insomnie (F51.0).
4. Arterielle Hypertonie (I10.90), Adipositas Grad I (E66.09).

Verlauf und Therapien

Die Rehabilitandin nahm an Physiotherapie in Einzel- und Gruppenform, Rückenschule, multimodaler Schmerzbewältigungsgruppe, psychologischen Einzelgesprächen und niedrig dosiertem Ergometertraining teil. Zwei Gruppentermine wurden wegen Schmerzexazerbation abgebrochen. Im psychologischen Einzelgespräch zeigte sich anhaltendes Grübeln mit Zukunftsangst; die Patientin war formal schwingungsfähig. Die Gehstrecke auf ebenem Gelände wurde mit 600 Metern angegeben, allerdings nur mit zwei Pausen. Treppensteigen gelang langsam am Geländer. Unter Anpassung der Analgesie kam es zu einer mäßigen Besserung der Schmerzspitzen, nicht jedoch der Belastbarkeit im Sitzen.

Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung

Entlassungsform: arbeitsunfähig.

Für die letzte berufliche Tätigkeit als Kassiererin und stellvertretende Schichtleitung im Baumarkt besteht ein Leistungsvermögen von unter drei Stunden täglich, da dort dauerhaftes Stehen, häufiges Heben, Kundenandrang und Kassentaktung anfallen.

Für leichte Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes wird ein Leistungsvermögen von sechs Stunden und mehr angenommen, soweit folgende Bedingungen eingehalten werden: Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Gehen möglich; keine Lasten über fünf Kilogramm; keine Zwangshaltungen; keine Akkord-, Fließband- oder Taktbedingungen; keine Nachtschicht; regelmäßige kurze Entlastungspausen.

Empfehlungen

Ambulante schmerztherapeutische Anbindung, Fortsetzung der laufenden Psychotherapie, Gewichtsreduktion, stufenweise Wiedereingliederung erst nach Stabilisierung. Ein aktuelles positives Leistungsbild für die bisherige Tätigkeit besteht nicht. Über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sollte nach Abschluss der Schmerztherapie entschieden werden.

gez. Dr. med. Stemmler, Chefarzt — Dr. med. Yilmaz, Stationsärztin

Befundbericht Orthopädie

Dr. med. Henning Lenz

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Orthopädische Praxis am Königsplatz

Königsplatz 36, 34117 Kassel

Telefon: 0561 70995-0

Patientin: Sabine Krüger, geboren am 14.02.1971

Befundbericht vom: 26.06.2026

Empfänger: Rentenberatung Sostmann, Kassel (mit Einverständnis der Patientin)

Sehr geehrte Damen und Herren,

über die oben genannte Patientin, die seit März 2024 in meiner regelmäßigen Behandlung steht, berichte ich wie folgt.

Befunde

Die Magnetresonanztomographie der Lendenwirbelsäule vom 11.02.2026 (Radiologie am Stern, Kassel) zeigt eine relevante Spinalkanalstenose L4/L5, Facettengelenksarthrosen L3 bis L5 und eine breitbasige Bandscheibenprotrusion L4/L5. Klinisch bestehen belastungsabhängige lumbale Schmerzen mit Ausstrahlung in das linke Bein, Sensibilitätsstörungen am lateralen linken Unterschenkel und eine deutliche Einschränkung beim längeren Stehen. Der Finger-Boden-Abstand beträgt 32 cm, das Zeichen nach Lasègue ist links bei 50 Grad positiv. Die Beschwerden nehmen unter axialer Belastung und in sitzender Position mit fehlender Entlastungsmöglichkeit zu.

Einschätzung des Leistungsvermögens

Aus orthopädischer Sicht halte ich die Leistungsbeurteilung des Reha-Entlassungsberichts für zu optimistisch. Im Praxisalltag kann Frau Krüger nach eigenen Angaben und nach wiederholter Beobachtung im Wartezimmer längeres Sitzen kaum durchhalten: Sie steht nach 20 bis 30 Minuten auf, geht wenige Schritte und setzt sich wieder. Stehen über 20 Minuten führt zu einer Schmerzzunahme mit Ausstrahlung. Eine Tätigkeit von sechs Stunden täglich wäre allenfalls denkbar, wenn jederzeit zwischen Sitzen, Stehen und Gehen gewechselt werden kann und zusätzliche, betriebsunübliche Pausen möglich sind. Solche Arbeitsbedingungen sind auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach meiner Erfahrung nicht ohne Weiteres üblich.

Weiteres Vorgehen

Ich habe eine schmerztherapeutische Vorstellung veranlasst; der Ersttermin im Schmerzzentrum Kassel ist für den 20.08.2026 vereinbart. Eine operative Dekompression wurde besprochen, wird aber wegen gemischter Schmerzursachen und der psychischen Belastung derzeit zurückhaltend bewertet. Eine erneute sozialmedizinische Begutachtung unter Einbeziehung des tatsächlichen Durchhaltevermögens und des Pausenbedarfs halte ich für erforderlich.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med. Henning Lenz

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Psychotherapeutische Verlaufsnotiz

Dipl.-Psych. Maren Wiegand

Psychologische Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie)

Praxisgemeinschaft Weserstraße 9, 34125 Kassel

Telefon: 0561 87342-11

Patientin: Sabine Krüger, geboren am 14.02.1971

Verlaufsnotiz vom: 29.06.2026

Zur Vorlage bei: Rentenberatung Sostmann (Schweigepflichtentbindung vom 26.06.2026 liegt vor)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Frau Krüger befindet sich seit dem 09.01.2026 in ambulanter verhaltenstherapeutischer Behandlung; bisher fanden 18 Sitzungen statt. Die Diagnose lautet rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode, mit chronischem Schmerzerleben und ausgeprägter Insomnie.

Hauptthemen der Behandlung sind der schmerzbedingte soziale Rückzug, die Angst vor der Aussteuerung aus dem Krankengeld, Schuldgefühle gegenüber der Tochter, anhaltender Schlafmangel und der Verlust der beruflichen Rolle. Die Patientin schildert Konzentrationsabbrüche bereits bei einfachen Formularen; sie benötigt die Hilfe ihrer Tochter beim Sortieren der Post und beim Ausfüllen von Anträgen.

In den Sitzungen zeigt sich ein deutlich wechselndes Bild. An guten Tagen kann Frau Krüger ein Gespräch über 45 Minuten führen und Vereinbarungen umsetzen. An schlechten Tagen verliert sie den Gesprächsfaden, wirkt psychomotorisch verlangsamt und weint. Eine rein sitzende Tätigkeit wird von ihr nicht als Entlastung erlebt, weil die Schmerzen im Sitzen zunehmen und den Schlafmangel verstärken. Publikumsverkehr und Zeitdruck führen zu Panikgefühlen und ausgeprägtem Vermeidungsverhalten; ein Einkauf zu Stoßzeiten wird nicht mehr allein unternommen.

Die rentenrechtliche Leistungsbeurteilung kann und will ich nicht abschließend treffen. Für eine Begutachtung rege ich jedoch ausdrücklich an zu prüfen, ob die Kombination aus chronifiziertem Schmerz, Schlafstörung und depressiver Symptomatik ein regelmäßiges Durchhaltevermögen an fünf Tagen in der Woche ausschließt oder nur an einzelnen guten Tagen eine mehrstündige Belastbarkeit besteht. Eine Momentaufnahme in einer einzigen Untersuchungssituation dürfte das schwankende Zustandsbild nicht abbilden.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Psych. Maren Wiegand

Arbeitgeberbeschreibung der bisherigen Tätigkeit

Baumarkt König GmbH & Co. KG

Betriebsstätte Kassel, Dresdener Straße 41, 34123 Kassel

Telefon: 0561 9502-0 | personal@baumarkt-koenig.de

Betrifft: Frau Sabine Krüger, Personalnummer 2081

Schreiben vom: 27.06.2026

An: Rentenberatung Sostmann, Kassel

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihre Anfrage vom 25.06.2026 beschreiben wir die Tätigkeit unserer Mitarbeiterin Frau Sabine Krüger wie folgt.

Frau Krüger ist seit dem 01.07.2008 bei uns beschäftigt, zuletzt mit 32 Wochenstunden als Kassiererin und stellvertretende Schichtleitung. Zu ihren Aufgaben gehörten der Kassendienst, die Bearbeitung von Kundenretouren, die Vertretung der Schichtleitung, die Mithilfe im Wareneingang bei Engpässen, der Kassenabschluss und die Telefonannahme. Die Arbeit erfolgte überwiegend im Stehen oder mit häufigem Aufstehen. Bei Retouren kamen regelmäßig Lasten bis zehn Kilogramm vor, vereinzelt auch darüber. In Stoßzeiten musste im Minutentakt kassiert werden; die Kassenzone ist zugluftbelastet.

Seit dem Frühjahr 2025 war Frau Krüger erkennbar eingeschränkt. Sie musste sich häufig setzen, konnte keine Getränkeboxen mehr anheben, vergaß bei Stress einzelne Kassivorgänge und bat Kolleginnen um Hilfe. Kundenbeschwerden nahmen zu, was Frau Krüger sichtbar belastete. Seit dem 18.09.2025 ist sie durchgehend arbeitsunfähig erkrankt.

Eine Umsetzung in die reine Telefonzentrale wurde geprüft, scheiterte aber daran, dass auch dort Kundenbeschwerden und durchgehende Bildschirmarbeit ohne flexible Pausen anfallen. Ein Arbeitsplatz im Homeoffice existiert in unserem Betrieb nicht. Einen leidensgerechten Arbeitsplatz, der jederzeitigen Haltungswechsel und zusätzliche Pausen erlaubt, können wir derzeit nicht anbieten.

Eine stufenweise Wiedereingliederung wurde im März 2026 mit Frau Krüger und der Krankenkasse besprochen, wegen der anstehenden Rehabilitationsmaßnahme und der Schmerzlage jedoch zurückgestellt. Wir sind bereit, das Gespräch nach einer Stabilisierung wieder aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Petra Hollstein

Personalleitung, Betriebsstätte Kassel

Tagesprotokoll Mandantin, Auszug Juni 2026

05.06.2026: Aufgewacht 04:20 Uhr wegen Schmerzen. Frühstück im Stehen, Sitzen am Küchentisch ging nur kurz. Weg zum Hausarzt 450 Meter mit zwei Pausen. Danach Mittagsschlaf zwei Stunden. Formular der DRV angefangen, nach zehn Minuten abgebrochen.

08.06.2026: Besserer Tag. Einkauf mit Tochter, im Laden nach 15 Minuten Schweißausbruch und Schmerzen. Tochter hat getragen. Abends Telefonat mit Schwester vergessen, obwohl Zettel am Kühlschrank hing.

14.06.2026: Schmerzspitze nach Wäschekorb. Ibuprofen, Wärmflasche, den Rest des Tages auf Sofa. Gedanken: "Ich falle allen zur Last." Keine Post geöffnet.

21.06.2026: Spaziergang an der Fulda 700 Meter langsam, drei Pausen. Danach Rücken brennend. Konzentration beim Lesen einer Zeitschrift etwa 20 Minuten.

28.06.2026: Bescheid gelesen und geweint. Tochter hat Termin bei Rentenberater gesucht. Angst vor Geldende.

Fristwahrender Widerspruch

Rentenberatung Sostmann

Albrecht Sostmann, Rentenberater (gerichtlich zugelassen)

Wilhelmsstraße 17, 34117 Kassel

Telefon: 0561 31661-0 | kanzlei@rentenberatung-sostmann.de

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Städelstraße 28

60596 Frankfurt am Main

Versicherungsnummer: 14 140271 K 507

Ihr Kennzeichen: EM-KRU-2026-0312

Kassel, den 06.07.2026

Widerspruch gegen den Bescheid vom 19.06.2026 – Rente wegen Erwerbsminderung; hier: Fristwahrung und Antrag auf Akteneinsicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich zeige an, dass mich Frau Sabine Krüger, geboren am 14.02.1971, Leipziger Straße 214, 34123 Kassel, mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat. Eine auf mich lautende Vollmacht ist beigelegt. Namens und im Auftrag von Frau Krüger lege ich gegen Ihren Bescheid vom 19.06.2026, zugegangen am 24.06.2026, mit dem der Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung vom 12.03.2026 abgelehnt wurde,

Widerspruch

ein.

Zur Begründung beantrage ich zunächst **Akteneinsicht**, insbesondere in die sozialmedizinische Auswertung Ihres Ärztlichen Dienstes, dessen Stellungnahmen, die zugrunde gelegten Tätigkeits- und Anforderungsprofile sowie die vollständigen Unterlagen der Rehabilitationsmaßnahme in Bad Zwesten. Nach Gewährung der Akteneinsicht wird der Widerspruch gesondert und substantiiert begründet; ich bitte, vorher keine Widerspruchsentscheidung zu treffen.

Bereits jetzt weise ich darauf hin, dass die Leistungsbeurteilung im Bescheid das tatsächliche Durchhaltevermögen der Widerspruchsführerin, ihren Pausenbedarf, die Notwendigkeit jederzeitigen Haltungswechsels, die dokumentierten Schmerzspitzen, die psychische Komorbidität mit wechselndem Tagesbild sowie die Anforderungen der bisherigen Tätigkeit nicht ausreichend abbildet. Die behandelnden Ärzte beurteilen das Leistungsvermögen deutlich kritischer als der Entlassungsbericht der Rehabilitationsklinik; auf die beigelegten Berichte von Dr. Lenz vom 26.06.2026 und Dipl.-Psych. Wiegand vom 29.06.2026 wird verwiesen.

Um Eingangsbestätigung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Albrecht Sostmann

Rentenberater

Anlagen: Vollmacht vom 03.07.2026; Befundbericht Dr. Lenz vom 26.06.2026; Verlaufsnotiz Dipl.-Psych. Wiegand vom 29.06.2026

Medizinische Beweisfragen

1. Welche Diagnosen sind gesichert, und welche funktionellen Einschränkungen folgen daraus im Alltag?
2. Wie lange kann Frau Krüger sitzen, stehen und gehen, jeweils ohne unübliche Pause?
3. Sind zusätzliche Pausen erforderlich, und falls ja, in welcher Häufigkeit und Dauer?
4. Kann sie regelmäßig an fünf Tagen je Woche sechs Stunden tätig sein oder nur zeitweise an guten Tagen?
5. Welche Auswirkungen haben Schmerzmittel auf Konzentration, Reaktionsfähigkeit und Publikumsverkehr?
6. **Ist die Wegefähigkeit gesichert, wenn 500 Meter nur mit Pausen gelingen?**
7. Welche Tätigkeiten scheiden wegen Kassenstress, Kundenbeschwerden, Taktung oder Bildschirmarbeit aus?
8. Ist eine Besserung binnen sechs Monaten wahrscheinlich, wenn Schmerztherapie erst beginnt?

Anlagen für Gutachten: Reha-Bericht, Orthopädie Dr. Lenz, Psychotherapie Wiegand, Arbeitgeberbeschreibung, Tagesprotokoll, Medikamentenplan.

Klagevorbereitung Sozialgericht

Falls der Widerspruchsbescheid die Ablehnung bestätigt, soll die Klage nicht nur Diagnosen wiederholen. Der Klagekern muss die Lücke zwischen Reha-Formel und tatsächlichem Arbeitsmarkt herausarbeiten: sechs Stunden nur bei idealer Wechselhaltung, zusätzlichen Pausen, fehlendem Takt, fehlendem Publikumsdruck und stabiler psychischer Lage. Gerade diese Bedingungen sind nicht selbstverständlich.

Mögliche Klageanträge: Aufhebung des Bescheids in Gestalt des Widerspruchsbescheids und Verurteilung zur Gewährung einer Rente wegen voller, hilfsweise teilweiser Erwerbsminderung ab 01.04.2026. Hilfsweise Einholung eines orthopädisch-psychiatrischen Sachverständigengutachtens.

Beweismittel: behandelnde Ärzte als sachverständige Zeugen, Arbeitgeberbeschreibung, Tagesprotokoll, Reha-Unterlagen, Medikamentenplan. Zusätzlich prüfen: Nahtlosigkeit, Krankengeldende, Antrag auf Leistungen zur Teilhabe, Schwerbehindertenverfahren.

Bundeseinheitlicher Medikationsplan (Übertrag)

Ausgedruckt von: Hausarztpraxis Dr. med. Katrin Ohlemacher

Allgemeinmedizin, Bettenhäuser Straße 78, 34123 Kassel

Telefon: 0561 57012-3

Patientin: Sabine Krüger, geboren am 14.02.1971

Stand: 22.06.2026

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Einnahme	Hinweis
Metamizol	Novaminsulfon	500 mg	1-1-1-1 bei Bedarf, max. 4x täglich	bei Schmerzspitzen
Ibuprofen	Ibuflam	600 mg	1-0-1	zu den Mahlzeiten, mit Magenschutz
Pantoprazol	Pantoprazol	40 mg	1-0-0	Magenschutz
Pregabalin	Pregabalin	75 mg	1-0-1	seit 04/2026, gegen ausstrahlende Schmerzen; macht nach Angabe der Patientin "wattig im Kopf"
Sertralin	Sertralin	100 mg	1-0-0	seit 02/2026, Verordnung in Abstimmung mit Psychotherapie
Ramipril	Ramipril	5 mg	1-0-0	Blutdruck
Zopiclon	Zopiclon	7,5 mg	0-0-0-1/2 bei Bedarf	höchstens dreimal je Woche, Schlafstörung

Ergänzende Hinweise der Hausärztin

Die Kombination aus Pregabalin, Sertralin und bedarfsweisem Zopiclon kann Konzentration, Reaktionsvermögen und Fahrtauglichkeit beeinträchtigen; die Patientin berichtet über Tagesmüdigkeit und Wortfindungsstörungen am Vormittag. Eine Dosissteigerung des Pregabalins wurde wegen dieser Nebenwirkungen bisher nicht vorgenommen. Die Schmerzmedikation soll im Rahmen der schmerztherapeutischen Vorstellung am 20.08.2026 neu geordnet werden.

Radiologischer Befund MRT der Lendenwirbelsäule

Radiologie am Stern

Dr. med. F. Brandenburg, Dr. med. S. Okafor

Kurt-Schumacher-Straße 4, 34117 Kassel

Telefon: 0561 22084-0

Patientin: Sabine Krüger, geboren am 14.02.1971

Untersuchung: MRT LWS nativ, 11.02.2026

Überweiser: Dr. med. Henning Lenz, Orthopädie

Befund vom: 12.02.2026

Klinische Angaben: Chronische Lumboischialgie links, Sensibilitätsstörungen lateraler linker Unterschenkel, Verdacht auf Spinalkanalstenose. Frage nach Neurokompression.

Technik: Sagittale T1- und T2-gewichtete Sequenzen, axiale T2-Sequenzen L3 bis S1, STIR sagittal.

Befund

Regelrechte Stellung der Lendenwirbelsäule bei leichter Steilstellung. Keine frische knöcherne Läsion, kein Nachweis eines entzündlichen Prozesses, keine suspekten Raumforderungen.

Segment L3/L4: Geringe Bandscheibendehydratation, flache dorsale Protrusion ohne relevante Enge, beginnende Facettengelenksarthrose beidseits.

Segment L4/L5: Deutliche Bandscheibendehydratation mit breitbasiger dorsaler Protrusion, hypertrophe Facettengelenksarthrose beidseits und Ligamenta-flava-Hypertrophie. Hierdurch hochgradige zentrale Spinalkanalstenose mit einem Restdurchmesser des Duralsacks von etwa 8 mm sowie Einengung des linken Recessus lateralis mit Kontakt zur abgehenden Wurzel L5 links.

Segment L5/S1: Mäßige Osteochondrose, kleine mediane Protrusion ohne Neurokompression.

Beurteilung

1. Hochgradige zentrale Spinalkanalstenose L4/L5 mit linksbetonter recessaler Enge und Wurzelkontakt L5 links, gut vereinbar mit der geschilderten linksseitigen Ausstrahlung und den Sensibilitätsstörungen.
2. Mehrsegmentale degenerative Veränderungen mit Facettengelenksarthrosen L3 bis L5.
3. Kein Anhalt für Fraktur, Entzündung oder Malignität.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med. F. Brandenburg